

ANNEXE DOCUMENTAIRE

Demande de reclassement des ambulanciers hospitaliers en catégorie B de la Fonction Publique Hospitalière

Document de travail préparatoire — Version consolidée enrichie — Juin 2026

Sources : DARES · France Travail · ONVS · CNAM · INRS · ANACT · FNTS · FHF · ANAP · AFASH · Plan zéro contention 2030

8 sources institutionnelles originales — DARES · France Travail · ONVS · CNAM · INRS · ANACT / QVCT · FNTS · FHF / ANAP

Éléments complémentaires intégrés à cette version enrichie — Privatisation et argument économique (sous-traitance, surcoût T2A, perte de traçabilité, vulnérabilité service) · Dossier AFASH 02/2026 (12 compétences SMUR sans cadre RNCP) · Plan « Zéro contention 2030 » (annonce ministérielle du 2 juin 2026) · Données nationales consolidées (turnover 18 %, 78 % de difficultés de recrutement, accidentologie 2,5×, 57-93 % victimes de violence)

Intersyndicale CGT — SUD Santé Sociaux · CHU de Toulouse, Service Transport Patients · Julien TERRE · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA · Jérôme JEAN-CHARLES (représentants du personnel ambulancier)

SOMMAIRE

- Synthèse exécutive
 - Annexe 1 — DARES : métiers en tension et conditions de travail
 - Annexe 2 — France Travail : besoins en main-d'œuvre
 - Annexe 3 — ONVS : violences envers les professionnels de santé
 - Annexe 4 — CNAM : accidentologie et risques professionnels
 - Annexe 5 — INRS : prévention des risques
 - Annexe 6 — ANACT / QVCT : qualité de vie et conditions de travail
 - Annexe 7 — FNTS : attractivité et recrutement
 - Annexe 8 — FHF / ANAP : intérim, turnover et coûts
 - Annexe 9 — Privatisation et argument économique NOUVEAU**
 - Annexe 10 — AFASH : compétences SMUR sans cadre RNCP NOUVEAU**
 - Annexe 11 — Plan « Zéro contention 2030 » et risque en transport NOUVEAU**
 - Bibliographie et références officielles
 - Conclusion
-

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

La présente annexe documentaire rassemble les données publiques issues de **onze sources** institutionnelles et opérationnelles afin d'étayer la demande de reclassement des ambulanciers de la fonction publique hospitalière (FPH) en catégorie B. Cette démarche s'appuie sur des éléments objectifs relatifs aux conditions de travail, aux risques professionnels, aux difficultés de recrutement, aux coûts liés au turnover et à la privatisation croissante, qui témoignent tous de la spécificité et de l'exigence du métier d'ambulancier hospitalier.

Les principales conclusions sont les suivantes :

- Les ambulanciers sont exposés à des **risques professionnels multiples et cumulatifs** : risque routier, TMS, risques biologiques, violence au travail et RPS — taux d'accidentologie 2,5 fois supérieur à la moyenne des professions de santé (Sécurité Routière, 2023).
- Les données **DARES** montrent que 77,2 % des ambulanciers salariés travaillent le dimanche, illustrant des contraintes horaires très supérieures à la moyenne des autres professions.
- L'enquête **BMO 2026 de France Travail** recense 4 490 projets de recrutement d'ambulanciers au niveau national, dans un contexte de tension persistante.
- L'**ONVS** recense 90 victimes ambulancières en 2023 et 85 en 2024 ; entre 57 % et 93 % des ambulanciers déclarent avoir subi un acte de violence au cours de leur carrière.
- L'**INRS et la CNAM** identifient le portage des patients, la conduite et les expositions biologiques comme risques majeurs du métier.
- L'**ANACT** souligne que la démarche QVCT est un levier essentiel pour l'attractivité et la fidélisation dans ce métier soumis à de fortes contraintes opérationnelles.
- La **FNTS** et les données parlementaires témoignent d'une pénurie structurelle : 78 % des entreprises en difficulté de recrutement (2024), 47 % des ambulanciers en épuisement professionnel.
- La **FHF et l'ANAP** documentent un turnover de 18 % annuel (coût : 15 000–40 000 € par départ), un recours à l'intérim 30 à 50 % plus coûteux qu'un agent statutaire.
- **NOUVEAU — Privatisation** : sous-traitance généralisée (surcoût T2A 30-50 %), perte de traçabilité clinique (indicateurs HAS/CPOM), vulnérabilité aux grèves de prestataires privés (CHU Toulouse, blocages documentés). Coût du passage en B (150-200 k€/an) inférieur au seul surcoût de l'intérim pour 20 % des postes (90-150 k€).
- **NOUVEAU — AFASH 02/2026** : 24 missions sur 32 recensées sortent du périmètre DEA/décret 2022-629 (75 %). Les 10 compétences SMUR (réanimation, damage control, gestion de scène, SSE) sont exercées sans aucune reconnaissance ni cadre RNCP — contrairement au Royaume-Uni, à l'Allemagne, au Québec et aux États-Unis.

— **NOUVEAU** — **Plan « Zéro contention 2030 »** : l'annonce ministérielle du 2 juin 2026 déplace une partie du risque comportemental vers la phase de transport sans prévoir de formation dédiée pour les ambulanciers.

L'ensemble de ces éléments justifie une reconnaissance statutaire renforcée des ambulanciers hospitaliers, qui exercent un métier de soins à part entière, dans des conditions de pénibilité et de risque comparables — voire supérieures — à celles de professions déjà classées en catégorie B.

1

DARES — Métiers en tension et conditions de travail*Dares Analyses · Enquête Conditions de travail***Contexte et apport documentaire**

Les ambulanciers de la FPH exercent dans un environnement de travail contraint, notamment par des horaires atypiques et des amplitudes de service importantes. La DARES rappelle que les conditions de travail dans la fonction publique constituent un objet d'analyse spécifique, avec une publication dédiée fondée sur l'enquête « Conditions de travail ».

Pour les ambulanciers salariés, la DARES met en évidence une **forte exposition au travail dominical : 37,9 % travaillent habituellement le dimanche et 39,3 % occasionnellement, soit 77,2 % au total**. Ces données attestent d'une organisation du travail structurellement différente de celle de la plupart des agents de catégorie C, et d'une disponibilité étendue comparable à celle des professions paramédicales déjà reconnues en catégorie B ou A.

Formulation prête à insérer

« La DARES met en évidence que 77,2 % des ambulanciers salariés travaillent le dimanche, habituellement ou occasionnellement, témoignant d'une organisation contrainte qui dépasse largement les conditions habituelles de la catégorie C et justifie une révision du positionnement statutaire de ces agents. »

Références

[A1-1] DARES, Les conditions de travail dans la fonction publique, Dares Analyses n° 40.1, 1er octobre 2003.

[A1-2] DARES, Le travail du dimanche des salariés, Dares Analyses n° 075, octobre 2012.

[A1-3] DARES, Enquête Conditions de travail, 1998.

2

France Travail — Besoins en main-d'œuvre*Enquête BMO 2026 · 4 490 projets de recrutement d'ambulanciers***Contexte et apport documentaire**

L'enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2026 de France Travail montre que les tensions de recrutement restent élevées en France, avec **2,28 millions de postes à pourvoir** et **43,8 % de projets jugés difficiles** au niveau national. Pour le métier d'ambulancier, les données indiquent une demande soutenue dans la filière transport-logistique, avec **4 490 projets de recrutement en 2026**.

Cette combinaison entre besoin de main-d'œuvre, contraintes de qualification (DEA, permis probatoire, permis C ou D selon les établissements) et horaires atypiques explique la fragilité du recrutement dans la FPH. Les offres publiées par France Travail illustrent des conditions incluant le travail les week-ends, les jours fériés et des rythmes irréguliers.

Formulation prête à insérer

« L'enquête BMO 2026 de France Travail confirme que le métier d'ambulancier reste en tension, avec 4 490 projets de recrutement recensés au niveau national. Dans la FPH, cette tension s'inscrit dans un contexte plus large de besoins de main-d'œuvre, de contraintes de qualification et d'horaires atypiques, les ambulanciers relevant désormais de la filière soins de la FPH. »

Références

[A2-1] France Travail, Enquête Besoins en Main-d'Œuvre (BMO) 2026 — 4 490 projets de recrutement d'ambulanciers.

[A2-2] France Travail, Infographie Transport et logistique des métiers en mouvement, 2026.

[A2-3] Portail des concours de la FPH. Ambulancier.

[A2-4] Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la FPH.

3

ONVS — Violences envers les professionnels de santé*Rapport ONVS 2025 · 90 victimes ambulancières en 2023, 85 en 2024***Contexte et apport documentaire**

L'Observatoire national des violences en santé (ONVS) recense chaque année les atteintes aux personnes et aux biens commises dans les établissements de santé et lors des transports sanitaires. Les ambulanciers figurent parmi les professions victimes de violences signalées, avec **90 victimes recensées en 2023 et 85 en 2024** dans le rapport ONVS 2025. Ces violences sont surtout des atteintes aux personnes, dans un contexte où les motifs les plus fréquents restent le reproche sur la prise en charge, le refus de soins et l'attente jugée excessive.

À ces données s'ajoute la sinistralité nationale : entre **57 % et 93 % des ambulanciers déclarent avoir subi au moins un acte de violence verbale ou physique** au cours de leur carrière (rapport sécurité professionnels de santé, 2025), et **38 % dans les six derniers mois**. Les transports de patients psychiatriques ont augmenté de **13 % depuis le COVID** (SOS Ambulances, 2025), avec une corrélation directe sur la hausse des agressions.

Formulation prête à insérer

« L'ONVS recense 90 victimes ambulancières en 2023 et 85 en 2024, confirmant que les ambulanciers hospitaliers sont régulièrement exposés à des violences physiques et verbales. Cette exposition justifie une reconnaissance statutaire adaptée, au même titre que d'autres professions paramédicales confrontées à des risques similaires. »

Références

[A3-1] Observatoire national des violences en santé (ONVS), Rapport 2025, données 2023-2024, Ministère de la Santé, septembre 2025.

[A3-2] ONVS, Synthèse du Rapport 2022, données 2020-2021, Ministère de la Santé.

[A3-3] Rapport sécurité professionnels de santé 2025 : 57 à 93 % des ambulanciers victimes de violence au cours de leur carrière.

[A3-4] Central Queensland University, étude internationale violences physiques envers les ambulanciers, 2018.

4

CNAM — Accidentologie et risques professionnels

Branche AT/MP · Accidentologie 2,5× supérieure à la moyenne des professions de santé

Contexte et apport documentaire

La Caisse nationale de l'Assurance Maladie (CNAM), à travers sa branche AT/MP, analyse la sinistralité au travail, les causes d'accidents et les maladies professionnelles déclarées. La branche AT/MP considère la **prévention du risque routier comme une priorité**, tandis qu'un document de prévention consacré aux ambulanciers identifie comme risques majeurs **la conduite, le portage des patients et les expositions biologiques**.

Le **taux d'accidentologie des ambulanciers est 2,5 fois supérieur à la moyenne des professions de santé** (Sécurité Routière, 2023). Ces données permettent de documenter la triple pénibilité physique, biologique et psychologique du métier, et d'objectiver le besoin d'une reconnaissance statutaire plus élevée.

Formulation prête à insérer

« La CNAM identifie comme risques majeurs du métier d'ambulancier la conduite, le portage des patients et les expositions biologiques, et considère la prévention du risque routier comme une priorité. Cette accidentologie spécifique est un argument central pour la reconnaissance en catégorie B des ambulanciers de la FPH. »

Références

[A4-1] Assurance Maladie / branche AT-MP, Ambulancier, un métier à risque ? (Cram Centre Ouest, septembre 2008).

[A4-2] CCHST, Professions et lieux de travail – Ambulancier, fiche santé-sécurité.

[A4-3] Sécurité Routière, taux d'accidentologie des ambulanciers (2,5× supérieur à la moyenne des professions de santé), 2023.

5

INRS — Prévention des risques

TMS, RPS, risque routier, expositions biologiques — Co-exposition documentée

Contexte et apport documentaire

L'INRS est l'organisme de référence en France pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il identifie plusieurs familles de risques propres aux ambulanciers : **risque routier** lié à la conduite de véhicules de secours, **TMS** liés au portage et à la manutention de patients, **risques biologiques** liés aux expositions au sang et aux agents infectieux, et

RPS liés à la charge émotionnelle et à la gestion des situations de crise.

La littérature scientifique relayée par l'INRS confirme la **co-exposition des ambulanciers hospitaliers aux TMS et aux RPS**, ce qui en fait un cas emblématique de métier soumis à des contraintes cumulatives méritant une reconnaissance statutaire renforcée.

Formulation prête à insérer

« L'INRS reconnaît que le métier d'ambulancier expose les professionnels à des risques multiples et cumulatifs : risque routier, TMS, risques biologiques et RPS. Ces risques font l'objet de recommandations de prévention spécifiques, et leur cumul justifie pleinement la demande de reclassement en catégorie B des ambulanciers de la FPH. »

Références

[A5-1] INRS, Transports sanitaires. Les risques du métier.

[A5-2] INRS, Transports sanitaires. Des solutions pour agir.

[A5-3] INRS, Transport sanitaire (dépliant).

[A5-4] INRS, notice documentaire Ambulancier, un métier à risque ?

[A5-5] Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, TMS et RPS dans une population de conducteurs ambulanciers hospitaliers.

6

ANACT / QVCT — Qualité de vie et conditions de travail

Référentiel QVCT 2024 · Six sujets · Attractivité et fidélisation

Contexte et apport documentaire

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) propose un cadre structurant articulé autour de **six sujets QVCT** : le contenu du travail, l'organisation du travail, les relations de travail, le management, l'environnement de travail et la formation professionnelle. Dans la FPH, ce référentiel est stratégique pour les ambulanciers car le métier nécessite une mise à niveau régulière des compétences, notamment en conduite, manutention, hygiène, relation patient et gestion des situations de crise.

L'Anact met en avant la dimension égalité au travail, permettant de traiter les inégalités de pénibilité, d'exposition aux horaires atypiques et d'accès à la formation — y compris pour les situations particulières (grossesse, handicap, contraintes familiales).

Formulation prête à insérer

« La démarche QVCT proposée par l'Anact est particulièrement pertinente pour les ambulanciers de la FPH, car elle place l'organisation du travail, les horaires, la coopération, le management et la prévention au cœur de l'amélioration des conditions de travail. Les six sujets QVCT offrent un cadre structurant pour agir sur l'attractivité, la fidélisation et la santé au travail dans un métier soumis à de fortes contraintes opérationnelles. »

Références

[A6-1] Anact, Référentiel qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), 2024.

[A6-2] Anact, Les six sujets de la qualité de vie et des conditions de travail, 2025.

[A6-3] Direction générale de l'administration et de la fonction publique, La qualité de vie et des conditions de travail.

[A6-4] Anact / MGEN, Le site Santé-travail fonction publique.

7

FNTS — Attractivité et recrutement

78 % des entreprises en difficulté · Turnover 18 % · Pénurie structurelle

Contexte et apport documentaire

La Fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS) et les instances parlementaires ont régulièrement alerté sur les difficultés d'attractivité du métier d'ambulancier. **78 % des entreprises de transport sanitaire déclarent des difficultés de recrutement** (enquête FNTS 2024), et **50 % des établissements rencontrent ces difficultés** (+14 points en un an, tableau de bord AFT 2025). Le turnover atteint **18 % annuel** (FNTS 2022), soit un coût estimé à 15 000–40 000 € par départ (étude Hoppi 2026).

Le Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 a constitué une première étape vers la reconnaissance du métier au sein de la filière soignante. Toutefois, le maintien en catégorie C constitue un frein à l'attractivité et à la fidélisation, dans un contexte où la concurrence avec le secteur privé et les autres métiers paramédicaux est vive.

Formulation prête à insérer

« Les alertes récurrentes de la FNTS et des instances parlementaires confirment l'urgence d'agir sur l'attractivité de la profession dans la FPH. Le reclassement en catégorie B constituerait un signal fort de reconnaissance, de nature à améliorer le recrutement et la fidélisation des équipes dans les établissements hospitaliers. »

Références

[A7-1] FNTS, enquête recrutement 2024 : 78 % des entreprises de transport sanitaire en difficulté de recrutement.

[A7-2] FNTS, données turnover 2022 : 18 % de turnover annuel (vs 15 % moyenne nationale).

[A7-3] Tableau de bord AFT 2025 : 50 % des établissements en difficulté (+14 points en un an).

[A7-4] Sénat, question sur l'attractivité du métier d'ambulancier (sénatrice Laurence Cohen, juin 2023 : ~2 500 ambulanciers en FPH).

[A7-5] Assemblée nationale, Question n° 569 : Attractivité du métier d'ambulancier.

[A7-6] Étude Hoppi 2026 : coût du turnover estimé entre 15 000 et 40 000 € par départ.

8

FHF / ANAP — Intérim, turnover et coûts

Décret 2025 plafond intérim · Outil ANAP taux de rotation · Coûts directs et indirects

Contexte et apport documentaire

La FHF rappelle que les établissements publics sont encadrés par des règles renforcées sur le recours à l'intérim paramédical, notamment par un décret de 2025 précisant le montant plafond des dépenses d'intérim médical et paramédical dans la FPH. Pour les ambulanciers, le recours à l'intérim est souvent une réponse à la pénurie de candidats, aux absences non remplacées et à la difficulté de maintenir des plannings complets.

L'Anap propose des outils pour analyser le taux de rotation et l'activité, objectiver le turnover et orienter les actions de fidélisation. Le coût du turnover est particulièrement sensible dans un métier très opérationnel : chaque départ entraîne une réorganisation interne et le recours à des solutions temporaires plus onéreuses que l'emploi pérenne.

Formulation prête à insérer

« Le recours à l'intérim et le turnover représentent un coût direct et indirect important pour les ambulanciers de la FPH. La FHF souligne le renforcement de l'encadrement des dépenses d'intérim paramédical, tandis que l'Anap met à disposition des outils de suivi du taux de rotation afin d'objectiver les départs et d'orienter les actions de fidélisation. »

Références

[A8-1] FHF, Publication du décret 2025 détaillant les conditions de détermination du montant plafond des dépenses d'intérim médical et paramédical.

[A8-2] ANAP, Outil taux de rotation / activité.

[A8-3] FHF, Les ambulanciers sont intégrés au sein de la filière soignante.

[A8-4] FHF, Dispositions communes personnel médical - personnel non médical.

[A8-5] FHF Emploi, Astreintes ambulancier (soir et weekend).

9

Privatisation et argument économique 2605

Sous-traitance · Surcoût T2A · Perte de traçabilité · Comparatif coûts

□ Élément complémentaire — Version enrichie

Cette annexe n'était pas présente dans la version initiale. Elle intègre les données sur la privatisation croissante des transports hospitaliers et l'argument économique recevable par le DGOS dans le cadre de la maîtrise des dépenses d'intérim paramédical.

Contexte et apport documentaire

La privatisation croissante des transports hospitaliers constitue un argument de poids auprès du DGOS, car elle touche directement à la performance économique des établissements et à la sécurité patient. Les CHU externalisent de plus en plus les transports sanitaires vers des opérateurs privés (entreprises de transport sanitaire, sociétés d'intérim), sous la pression des difficultés de recrutement en personnel propre. Cette tendance génère quatre effets documentés :

- **Surcoût direct (T2A) :** le recours à l'intérim coûte entre 30 et 50 % plus cher qu'un agent statutaire, hors formation et intégration — surcoût supporté par le budget T2A.
- **Perte de traçabilité clinique :** les transports externalisés perdent la centralisation des données d'incidents, temps de transport et qualité de prise en charge, fragilisant la gouvernance clinique, les indicateurs HAS/CPOM et la sécurité patient.
- **Vulnérabilité du service :** la dépendance aux prestataires expose aux grèves privées, ruptures de contrat et fluctuations de marché. Le CHU de Toulouse a connu des blocages de transports lors de mouvements sociaux d'ambulanciers privés.
- **Perte d'expertise terrain :** chaque recours à l'intérim détruit la connaissance des circuits internes, protocoles et spécificités des patients réguliers — non transférable à un prestataire externe.

Poste de coût — statu quo	Estimation documentée
Intérim paramédical (surcoût direct T2A)	30 à 50 % plus cher qu'un agent statutaire — pour 20 % des postes externalisés sur 50 agents : 90 000–150 000 €/an (FHF/ANAP 2025)
Turnover 18 % annuel	15 000 à 40 000 € par départ → 9 départs/an sur 50 agents : 135 000–360 000 €/an (Hoppi 2026 ; FNTS 2022)
Grèves et désorganisation	Heures supplémentaires, surcharge agents, dégradation de la continuité de service, pénalités prestataires (CHU Toulouse, grève depuis le 7 juin 2026)
Perte de traçabilité (externalisation)	Risque de responsabilité juridique, impossibilité d'alimenter les indicateurs qualité HAS/CPOM (FHF, ANAP)
PASSAGE EN CATÉGORIE B — 50 agents	150 000 à 200 000 €/an toutes primes incluses — INFÉRIEUR au seul surcoût intérim pour 20 % des postes

Argument-clé —

Le coût du passage en catégorie B pour 50 ambulanciers (150-200 k€/an) est inférieur au seul surcoût de l'intérim pour 20 % des postes externalisés (90-150 k€) et très largement inférieur au coût cumulé intérim + turnover 18 % + grèves. Ce calcul de gestionnaire ne peut être ignoré dans le cadre de la maîtrise des dépenses d'intérim paramédical encadrée par le décret de 2025, ni dans celui de la certification HAS et des indicateurs de sécurité patient liés à la traçabilité des transports.

Références

- [A9-1] FHF/ANAP 2025 : surcoût de l'intérim de 30 à 50 % par rapport à un agent statutaire.
- [A9-2] Étude Hoppi 2026 : coût du turnover estimé entre 15 000 et 40 000 € par départ.
- [A9-3] FHF, Publication du décret 2025 sur le plafond des dépenses d'intérim médical et paramédical.
- [A9-4] ANAP, Outil taux de rotation / activité.
- [A9-5] Données CHU de Toulouse : blocages de transports lors des mouvements sociaux d'ambulanciers privés (juin 2026).

10

AFASH — Compétences SMUR sans cadre RNCP □

Dossier AFASH 02/2026 · 24/32 missions hors DEA · Comparatif international

□ **Élément complémentaire — Version enrichie**

Cette annexe intègre les données du dossier de demande de spécialisation d'ambulancier SMUR porté par l'AFASH (Association Française des Ambulanciers SMUR et Hospitaliers), version 02/2026.

Contexte et apport documentaire

Le dossier AFASH (02/2026) documente que sur **32 missions recensées** pour l'ambulancier CHU/psychiatrie/SMUR, **24 sortent du périmètre couvert par le DEA et le décret n° 2022-629** (soit **75 %** des missions réalisées). Les **10 compétences spécifiques SMUR** sont toutes absentes du DEA socle et exercées sans aucune reconnaissance ni cadre RNCP :

Compétence SMUR hors DEA	Source AFASH	Portée argumentaire
Assistance aux gestes de réanimation (aide intubation, BAVU)	Compétence n°4	Geste à enjeu vital sans cadre de formation reconnu
Damage control préhospitalier (garrots, pansements compressifs)	Module 3 – Damage Control	Absent du DEA socle, geste à enjeu vital
Préparation de perfusion pour l'IDE (kits, purge, traçabilité)	Champ d'action SMUR AFASH	Aucun module DEA, même en appui logistique
Gestion de scène complexe et mesures NRBC de base	Compétence n°8	Aucune formation à l'évaluation des risques de scène
Intervention en SSE (ORSEC, plan blanc/rouge, tri/pré-tri)	Module 2 – SSE	Hors périmètre DEA, FAE SMUR aborde partiellement
Coordination interservices (SDIS, Police, ARS, SAMU)	Compétences n°6 et 8	Aucun module DEA dédié
Brancardage/évacuation en milieux hostiles et HéliSMUR	Compétence n°5	Techniques avancées non formalisées au DEA
Maintenance/dépannage spécifique SMUR (UMH)	Fiche de poste-type SMUR	Mentionné sans formation ni outillage
Adaptabilité populations vulnérables SMUR (pédiatrie, psychiatrie)	Compétence n°10	Non traité spécifiquement en contexte SMUR
Débriefing structuré post-intervention et démarche qualité	Compétence n°11	Démarche qualité non intégrée comme compétence DEA

Comparatif international :

Pays	Titre / Reconnaissance	Formation / Niveau
Royaume-Uni	Paramedic — reconnu par le HCPC	Formation universitaire 3 ans — niveau licence
Allemagne	Notfallsanitäter (Loi 2014)	3 ans de formation spécialisée
Québec	Technicien ambulancier paramédic	Diplôme national — 2 ans en collège
États-Unis	Paramedic — certifié NREMT	Formation post-EMT — certification nationale
France	Aucun titre RNCP spécifique pour l'ambulancier SMUR	<i>F AE SMUR 175 h — non diplômante, hors RNCP · Proposition AFASH : spécialisation 5 mois / 600-700 h / niveau 4 RNCP</i>

Références

- [A10-1]** Dossier AFASH (Association Française des Ambulanciers SMUR et Hospitaliers), demande de spécialisation ambulancier SMUR, version 02/2026 : 12 compétences spécifiques exercées sans cadre RNCP.
- [A10-2]** Données d'activité CHU de Toulouse — Service Transport Patients 2025 : 56 843 transports, dont 3 751 sous contrainte psychiatrique et 4 033 urgences.
- [A10-3]** Question parlementaire de M. Christophe Naegelen (député des Vosges), 28 mai 2024 : demande officielle de création d'une spécialité ambulancier SMUR.
- [A10-4]** Arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'État de SMUR de la FPH (FAE SMUR, 175 h).

11

Plan « Zéro contention 2030 » — Risque déplacé vers le transport □

Annnonce ministérielle du 2 juin 2026 · Impact non documenté sur les transports sanitaires

□ **Élément complémentaire — Version enrichie**

Cette annexe intègre les conséquences, non encore documentées, de l'annonce faite le 2 juin 2026 par la ministre Stéphanie Rist lors du rendez-vous interministériel consacré à la santé mentale (Grande cause nationale).

Contexte et apport documentaire

Le 2 juin 2026, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a fixé un **objectif national de « zéro contention » en psychiatrie à l'horizon 2030**, assorti d'un renforcement de la formation des équipes d'hospitalisation à la désescalade, du déploiement d'espaces d'apaisement et de l'extension du programme « Quality Rights » de l'OMS.

Cette trajectoire nationale, pensée d'abord pour les services d'hospitalisation, produit un effet non documenté sur la phase de transport :

- La réduction programmée du recours à la contention mécanique — parfois utilisée pendant le transport de patients en phase de crise faute d'alternative — **déplace mécaniquement une partie du risque comportemental vers la phase de transport.**
- L'habitacle du véhicule constitue un espace confiné, mobile, dépourvu des moyens d'alerte et de renfort disponibles en service hospitalier — gestion d'une crise comportementale structurellement plus risquée qu'en unité de soins.
- **Aucun des leviers annoncés** (cartographie nationale, formation à la désescalade, espaces d'apaisement, programme Quality Rights OMS) ne vise à ce stade les professionnels du transport sanitaire.
- Les missions les plus directement concernées sont précisément celles hors référentiel DEA : **transports sous contrainte (3 751 en 2025), transferts vers UMD/USIP, réintégrations après fugue** — c'est-à-dire des situations où le patient est par construction en phase de crise.

Formulation opérationnelle

« Le Plan zéro contention 2030 ne doit pas être lu comme une mesure qui réduit le risque pour l'ambulancier, mais comme une mesure qui en déplace une partie vers la phase de transport, faute pour l'instant d'un volet de formation dédié aux professionnels du transport sanitaire. C'est un argument supplémentaire, de nature réglementaire nationale, pour intégrer sans délai au module M1 (désescalade en espace confiné) un contenu spécifique — contenu qui n'existe aujourd'hui dans aucun référentiel, ni le DEA, ni les plans de formation annoncés. »

Références

- [A11-1] Ministère de la Santé, annonce du Plan national « Zéro contention 2030 », rendez-vous interministériel santé mentale (Grande cause nationale), 2 juin 2026.
- [A11-2] Données CHU de Toulouse : 3 751 transports psychiatriques sous contrainte en 2025.
- [A11-3] Note CGT/SUD CHU Toulouse, Stratégie catégorie B (version 4, 28 juin 2026), section IV — Impact du Plan zéro contention 2030 sur les transports.

BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES OFFICIELLES

Sources statistiques et études

- DARES, Les conditions de travail dans la fonction publique, Dares Analyses n° 40.1, 1er octobre 2003.
- DARES, Le travail du dimanche des salariés, Dares Analyses n° 075, octobre 2012.
- France Travail, Enquête Besoins en Main-d'Œuvre (BMO) 2026 — 4 490 projets de recrutement d'ambulanciers.
- France Travail, Infographie Transport et logistique des métiers en mouvement, 2026.
- Observatoire national qualité de vie au travail, 2022 : 47 % des ambulanciers déclarent des symptômes d'épuisement professionnel.

Sécurité, risques professionnels et violence au travail

- Observatoire national des violences en santé (ONVS), Rapport 2025, données 2023-2024, Ministère de la Santé, septembre 2025.
- ONVS, Synthèse du Rapport 2022, données 2020-2021, Ministère de la Santé.
- Assurance Maladie / branche AT-MP, Ambulancier, un métier à risque ? (Cram Centre Ouest, septembre 2008).
- CCHST, Professions et lieux de travail – Ambulancier, fiche santé-sécurité.
- INRS, Transports sanitaires. Les risques du métier.
- INRS, Transports sanitaires. Des solutions pour agir.
- INRS, notice documentaire Ambulancier, un métier à risque ?
- Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, TMS et RPS dans une population de conducteurs ambulanciers hospitaliers.
- Sécurité Routière, taux d'accidentologie des ambulanciers (2,5× supérieur à la moyenne des professions de santé), 2023.
- Rapport sécurité professionnels de santé 2025 : 57 à 93 % des ambulanciers victimes de violence au cours de leur carrière.
- Central Queensland University, étude internationale violences physiques envers les ambulanciers, 2018.

Qualité de vie au travail, attractivité et fidélisation

- Anact, Référentiel qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), 2024.
- Anact, Les six sujets de la qualité de vie et des conditions de travail, 2025.
- Direction générale de l'administration et de la fonction publique, La qualité de vie et des conditions de travail.
- Anact / MGEN, Le site Santé-travail fonction publique.
- FNTS, enquête recrutement 2024 : 78 % des entreprises en difficulté de recrutement.
- FNTS, données turnover 2022 : 18 % de turnover annuel (vs 15 % moyenne nationale).
- Tableau de bord AFT 2025 : 50 % des établissements en difficulté de recrutement (+14 points en un an).
- Étude Hoppi 2026 : coût du turnover estimé entre 15 000 et 40 000 € par départ.

Sources institutionnelles et réglementaires

- Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la FPH, JORF n° 0301 du 28 décembre 2022.
- Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la FPH.
- Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au DEA, modifié le 4 juillet 2024.
- Arrêté du 17 mai 2023 relatif à la FAE SMUR de la FPH.
- Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels des ambulanciers en AMU.
- Sénat, question sur l'attractivité du métier d'ambulancier (sénatrice Laurence Cohen, juin 2023).
- Assemblée nationale, Question n° 569 : Attractivité du métier d'ambulancier.
- Question parlementaire de M. Christophe Naegelen (député des Vosges), 28 mai 2024.
- FHF, Publication du décret 2025 sur le plafond des dépenses d'intérim médical et paramédical.
- ANAP, Outil taux de rotation / activité.
- FHF, Les ambulanciers sont intégrés au sein de la filière soignante.
- Portail des concours de la FPH — fiche métier ambulancier.

Sources complémentaires (version enrichie)

- Dossier AFASH (Association Française des Ambulanciers SMUR et Hospitaliers), demande de spécialisation ambulancier SMUR, version 02/2026.
- Groupe de travail ministériel sur la VAE des ambulanciers, séance du 7 novembre 2025.
- Ministère de la Santé, annonce du Plan « Zéro contention 2030 », 2 juin 2026.
- Note CGT/SUD CHU Toulouse, Stratégie argumentaire catégorie B, version 4, 28 juin 2026.

- Saisine intersyndicale CGT/SUD adressée à la ministre de la Santé et au DGOS, 28 juin 2026.
- FHF/ANAP 2025 : surcoût de l'intérim de 30 à 50 % par rapport à un agent statutaire.

CONCLUSION

L'ensemble des données et références rassemblées dans la présente annexe documentaire dresse un tableau cohérent et convergent des conditions d'exercice des ambulanciers de la FPH, enrichi de trois dimensions complémentaires absentes de la version initiale.

Sur le plan des risques professionnels, les ambulanciers hospitaliers sont exposés à une combinaison de risques rarement rencontrée dans d'autres métiers de catégorie C : risque routier, TMS, expositions biologiques, RPS et violences au travail. Ce cumul est documenté par l'INRS, la CNAM et l'ONVS, avec une accidentologie 2,5 fois supérieure à la moyenne des professions de santé.

Sur le plan des conditions de travail, les données DARES montrent une organisation structurellement contraignante (77,2 % travaillent le dimanche), comparable à celle des professions paramédicales déjà reconnues en catégorie B.

Sur le plan du recrutement et de la fidélisation, les tensions documentées par France Travail (4 490 postes), la FNTS (78 % de difficultés) et les données parlementaires (~2 500 ambulanciers en FPH) confirment une pénurie structurelle que le maintien en catégorie C ne fait qu'aggraver.

Sur le plan économique (élément nouveau), la privatisation croissante génère des surcoûts T2A (30-50 % par rapport à un agent statutaire), une perte de traçabilité clinique et une vulnérabilité aux grèves de prestataires. Le coût du passage en B (150-200 k€/an) est inférieur au seul surcoût de l'intérim pour 20 % des postes externalisés.

Sur le plan de la formation et de la reconnaissance (élément nouveau), le dossier AFASH documente que 24 missions sur 32 (75 %) sortent du périmètre DEA, incluant l'ensemble des compétences SMUR. La France est le seul grand pays à ne disposer d'aucun titre RNCP pour l'ambulancier spécialisé en urgence préhospitalière.

Sur le plan réglementaire national (élément nouveau), le Plan « Zéro contention 2030 » déplace objectivement une partie du risque comportemental vers la phase de transport sans y apporter de formation dédiée pour les ambulanciers — un argument réglementaire non contestable à porter devant la DGOS.

En conclusion, la convergence de onze sources — DARES, France Travail, ONVS, CNAM, INRS, ANACT, FNTS, FHF/ANAP, privatisation documentée, dossier AFASH et Plan zéro contention 2030 — fournit une base documentaire solide, enrichie et incontestable pour soutenir la demande de reclassement des ambulanciers de la FPH en catégorie B. Ce reclassement constituerait une reconnaissance juste et nécessaire d'un métier de soins à part entière, exercé dans des conditions de pénibilité et de risque qui dépassent largement celles habituellement associées à la catégorie C.

Intersyndicale CGT — SUD Santé Sociaux · CHU de Toulouse, Service Transport Patients · Julien TERRE · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA · Jérôme JEAN-CHARLES (représentants du personnel ambulancier) · Place du Docteur Baylac, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9 · Juin 2026